Faculté de Médecine d'Oran
Ministère de l'enseignement supérieur

Syncopes et Lipothymies



Cours 3e année Médecine
Sémiologie médicale

Pr Ag Hamdaoui.MS
Médecine Interne EHUO





08.10.2025
15.10.2025

❑OBJECTIFS

- Reconnaître une **syncope et une lipothymie.**
- Connaitre les **situations** qui peuvent prêter à confusion et qui ne sont ni lipothymie ni syncope
- Savoir mener un **interrogatoire** et examiner un patient victime d'un malaise
- Evoquer les causes fréquentes (cardiovasculaires)

Identifier une hypotension artérielle orthostatique.

- Rechercher les éléments d'orientation sur un ECG per ou post malaise.
- Demander un bilan minimal de première intention pour guider le diagnostic de certitude.

1. DÉFINITIONS

❑ Syncope :

- trouble de conscience avec hypotonie – et perte du tonus postural – de **début brutal ou rapide et spontanément régressif**, en général bref.

- Après le retour à la conscience, l'état neurologique, notamment le comportement, et l'orientation sont **normaux**.

- Une amnésie brève est assez fréquente (le patient n'a pas souvenir d'avoir perdu connaissance).

- **Lipothymie**:

  (ou *pré-syncope)*

  syncope « incomplète » qui ne va pas jusqu'à la perte de tonus postural ou pas jusqu'à la perte de contact.

  => Elle peut se résumer à une sensation imminente de perte de connaissance.

Phénomène d'Adams-Stokes :

- une syncope à début brutal précédé de pâleur, de durée < 30 secondes avec retour abrupt à une conscience normale dont l'étiologie est **cardiaque et rythmique**.

- On parle aussi de : syncope à «l'emporte-pièce ».





2. PHYSIOPATHOLOGIE

1. HYPOPERFUSION CÉRÉBRALE

- Le débit sanguin cérébral est de 50–60 mL/min par 100 g de tissu.
  La substance réticulée activatrice du tronc cérébral responsable de l'état de conscience ne reçoit pas ses besoins en oxygène lorsque la pression artérielle systolique est < 60 mm Hg ou après 6 à 8 secondes d'arrêt de la circulation.

- Toute baisse des apports soit par arrêt bref de la circulation sanguine (ou inefficacité circulatoire), soit par hypotension artérielle (quelle qu'en soit la cause) peut donc entraîner syncope ou lipothymie.

2.TROIS MÉCANISMES DIFFÉRENTS POUR CETTE HYPOPERFUSION:

- Arrêt temporaire de la circulation sanguine de cause électrique (par ex. : asystolie ou tachycardie ventriculaire).

- Arrêt temporaire de la circulation sanguine de cause mécanique (par ex. : embolie pulmonaire massive ou thrombose de valve mécanique).

- Hypotension artérielle profonde et brutale à débit cardiaque préservé, survenant donc à cause d'une vasodilatation :

(selon la loi pression = débit × résistances artérielles)

=> soit intrinsèque (hypo volémie),
=> soit extrinsèque (médicaments),
=> soit réflexe.

Dans ce cadre, il s'agit d'une activation particulière du système nerveux autonome qui associe une vasodilatation de cause centrale (levée du tonus vasomoteur) à une bradycardie (activation vagale des nerfs pneumogastriques) nommée **réaction vaso-vagale**

3.TROIS CONSÉQUENCES POUR CETTE HYPOPERFUSION

- Perte de conscience complète (syncope), parfois incomplète (lipothymie).
- Perte du tonus postural complète (syncope) parfois incomplète (lipothymie).
- Myoclonies au-delà de 30 secondes : elles sont fréquentes, brèves, durent moins de 15 secondes, elles débutent toujours après la perte de connaissance.

Attention!!

- *Il ne s'agit pas de crise comitiale, il faut d'ailleurs éviter de parler de « syncope convulsivante » mais utiliser le terme de myoclonies sur syncope un peu prolongée.*

3.Diagnostic différentiel

1. Confusion mentale : état avec déficit d'attention et de concentration, désorientation, hallucinations, propos incohérents et agitation.

2. Crise comitiale : perte de connaissance prolongée avec signes focaux initiaux ou postcritiques:
Dans sa forme généralisée, il y a une crise tonico-clonique puis une phase résolutive. Elle s'accompagne de morsure de langue (latérale et profonde) et d'une confusion post-critique.

3.Accident vasculaire cérébral ou infarctus cérébral :

déficit ou signes neurologiques de début brutal liés à l'interruption du flux sanguin dans une région spécifique du cerveau.

4.Cataplexie :

perte brusque du tonus musculaire sans altération de la conscience typiquement déclenchée par une émotion.

5.Narcolepsie ou maladie de Gélineau :

cataplexie associée à des accès irrépressibles de sommeil survenant plusieurs fois par jour et durant de quelques secondes à 30 minutes.

- **6.TROUBLES DE CONSCIENCE DE CAUSE MÉTABOLIQUE OU TOXIQUE:**

● Causes métaboliques :
○ hypoglycémie ;
○ hypoxie – hypercapnie (ou encéphalopathie respiratoire) ;
○ encéphalopathie hépatique.

● Causes toxiques :
○ toxicomanie ;
○ intoxication médicamenteuse ;
○ alcoolisation +++ ;
○ monoxyde de carbone +++.

- **7.MALADIES PSYCHIATRIQUES**

- Trouble de conversion (névrose hystérique), présence d'un témoin et généralement pas de blessure.

- Attaque de panique (anciennement « tétanie » ou « spasmophilie »).

- Trouble factice (simulation).

8.TROUBLES DE CONSCIENCE DE CAUSE NEUROLOGIQUE OU NEUROVASCULAIRE

Ces troubles de conscience se produisent :

- avec déficit lors des infarctus cérébraux ou des accidents ischémiques transitoires

- au cours de l'épilepsie et des crises comitiales

- en cas d'insuffisance vertébro-basilaire, ou d'artère sous-clavière « voleuse », le trouble est induit par les mouvements répétés des bras, on note une différence de

pression artérielle ou de pouls entre les deux bras ;

- au cours de *drop attacks*

4.Démarche diagnostique

1.INTERROGATOIRE

- L'interrogatoire du patient et surtout des témoins est crucial, il a pour objectif de faire préciser quatre éléments clés :

○ l'âge,

○ les antécédents familiaux de mort subite chez un jeune, orientant vers une: cardiopathie de cause génétique,

○ les antécédents personnels de cardiopathie chez une personne d'âge mûr: orientant vers un trouble du rythme,

○ les prises médicamenteuses, avec une mention particulière des médicaments hypotenseurs (demander aux proches le cas échéant) ;

- Préciser la posture au moment de la syncope : debout – assis– couché et l'activité : effort ou repos

- Demander aux témoins de préciser d'éventuels mouvements anormaux : crise tonicoclonique ou simple clonie et s'ils ont été contemporains (crise comitiale) ou retardés (myoclonie) par rapport à la perte de connaissance

- Préciser la durée, en sachant qu'une amnésie passagère peut égarer le patient sur la durée exacte, le mode de réveil, brutal ou progressif avec ou sans phase post-critique…

- Rechercher la présence de nausées, vomissements, de sueurs abondantes, d'une sensation de froid, d'une perte urinaire ,,,

- demander au patient s'il est courbaturé (crise comitiale)

2.EXAMEN CLINIQUE

L'examen neurologique

- des signes déficitaires, on quitte alors le domaine cardiovasculaire en cas d'anomalies, ou d'une altération prolongée de l'état de conscience (confusion ou coma).

- La morsure profonde du bord latéral de langue évoque une crise comitiale, l'interrogatoire peut y avoir fait penser en cas d'insomnie, de stimulation lumineuse intermittente de sevrage médicamenteux ou éthylique.

- L'entourage précise les mouvements anormaux, on note des déficits transitoires un syndrome confusionnel postcritique

- L'examen cardiovasculaire permet souvent d'identifier à ce stade les causes « mécaniques », par exemple en cas de **souffle systolique de rétrécissement aortique**, de signes de **cœur pulmonaire aigu**, etc.

- La pression artérielle, surtout au décours immédiat de la syncope, et la constatation d'une hypotension prolongée ont une grande valeur d'orientation en faveur d'une **hypotension iatrogène ou réflexe**. Il faut aussi rechercher **l'hypotension artérielle orthostatique**

- L'abolition du pouls radial signifie simplement que la pression artérielle systolique est basse (ce qui peut se voir en cas **de syncope vaso-vagale**), rechercher plutôt le pouls carotidien.

3. ÉLECTROCARDIOGRAMME

- Il permet de donner le diagnostic devant les anomalies suivantes :

- Dysfonction sinusale si bradycardie sinusale < 40 bpm ou pauses > 3 secondes,
- Tachycardie ventriculaire (QRS larges),
- Tachycardie supraventriculaire (QRS fins) rapide > 150 bpm
- Bloc atrioventriculaire complet ou du deuxième degré de type Möbitz II ou bloc alternant évocateur d'un bloc trifasciculaire,
- Signes de défaillance d'un stimulateur cardiaque (pacemaker)

- Syndrome de pré excitation (Wolff-Parkinson-White) qui oriente vers une tachycardie jonctionnelle paroxystique
- Extrasystoles ventriculaires nombreuses ou en salves
- Allongement de l'intervalle QT (oriente vers une torsade de pointes),
- Troubles de repolarisation, ondes Q de nécrose, aspect d'hypertrophie ventriculaire gauche orientent vers une maladie coronarienne ou une myocardiopathie).

le diagnostic n'est toujours pas établi, mais on décèle soit :

- des anomalies de l'ECG d'orientation .

- des arguments pour la présence d'une cardiopathie sous-jacente et dans ce cas c'est l'hypothèse d'un trouble du rythme ventriculaire annonciateur de mort subite qui domine +++ ;

- un ECG normal et des données cliniques ne mettant pas en évidence de pathologie cardiaque sous-jacente ; il faut dans ce cas savoir poursuivre les examens para-cliniques pour s'en assurer…

4. EXAMENS PARACLINIQUES SPÉCIALISÉS

- Ils sont pratiqués pour vérifier l'absence de cardiopathie sous-jacente :

- Echocardiographie trans-thoracique
- Test d'effort
- Brain Natriuretic Peptide BNP et pro BNP

- **Holter ECG** (patient hospitalisé ou en ambulatoire).

- *L'étude électrophysiologique endocavitaire* +++.

- Un *moniteur ECG implantable peut être pratiqué*

❑CRITÈRES DE GRAVITÉ

- *L'hospitalisation est immédiate en cas de :*

- Diagnostic avéré ou supposé (sur les données ECG), de **trouble du rythme ventriculaire ou de trouble de conduction**

- Syncope inexpliquée chez un cardiaque notamment avec **séquelle d'infarctus**, en raison du risque de mort subite ++

- Suspicion de maladie génétique chez un sujet jeune (antécédents familiaux de mort subite) ;

- syncope avec traumatisme grave quel que soit le contexte, d'effort ou survenue au décubitus.

5.ÉTIOLOGIES DES SYNCOPES ET LIPOTHYMIES

- **1 CAUSES CARDIAQUES « MÉCANIQUES »**

- **Rétrécissement aortique**, en général calcifié et serré, du sujet âgé ou sur bicuspidie ; la syncope est typiquement décrite à l'effort ;

- **Myocardiopathies hypertrophiques obstructives** : il s'agit de maladies de cause génétique, Il y a à l'effort un obstacle à l'éjection ventriculaire gauche entre le septum hypertrophié et la valve mitrale, l'auscultation retrouve un souffle systolique au bord gauche du sternum.

- **Embolie pulmonaire**, par obstacle sur thrombus occlusif ou sub-occlusif ;

- **Tamponnade** lors de la constitution brutale d'un épanchement péricardique qui comprime les cavités cardiaques droites.

2.CAUSES CARDIAQUES « ÉLECTRIQUES »

- **Tachycardies**
  - *tachycardies ventriculaires, Syndrome Coronarien Aigu*
  - torsades de pointes en cas d'allongement de l'intervalle QT ;
  - tachycardies supraventriculaires : flutter à conduction ou tachycardie jonctionnelle, ou au cours du syndrome de Wolff-Parkinson-White .

- **Blocs atrioventriculaires** :
  - BAV du troisième degré ++
  - beaucoup plus rarement du deuxième degré, type Möbitz I ou II.

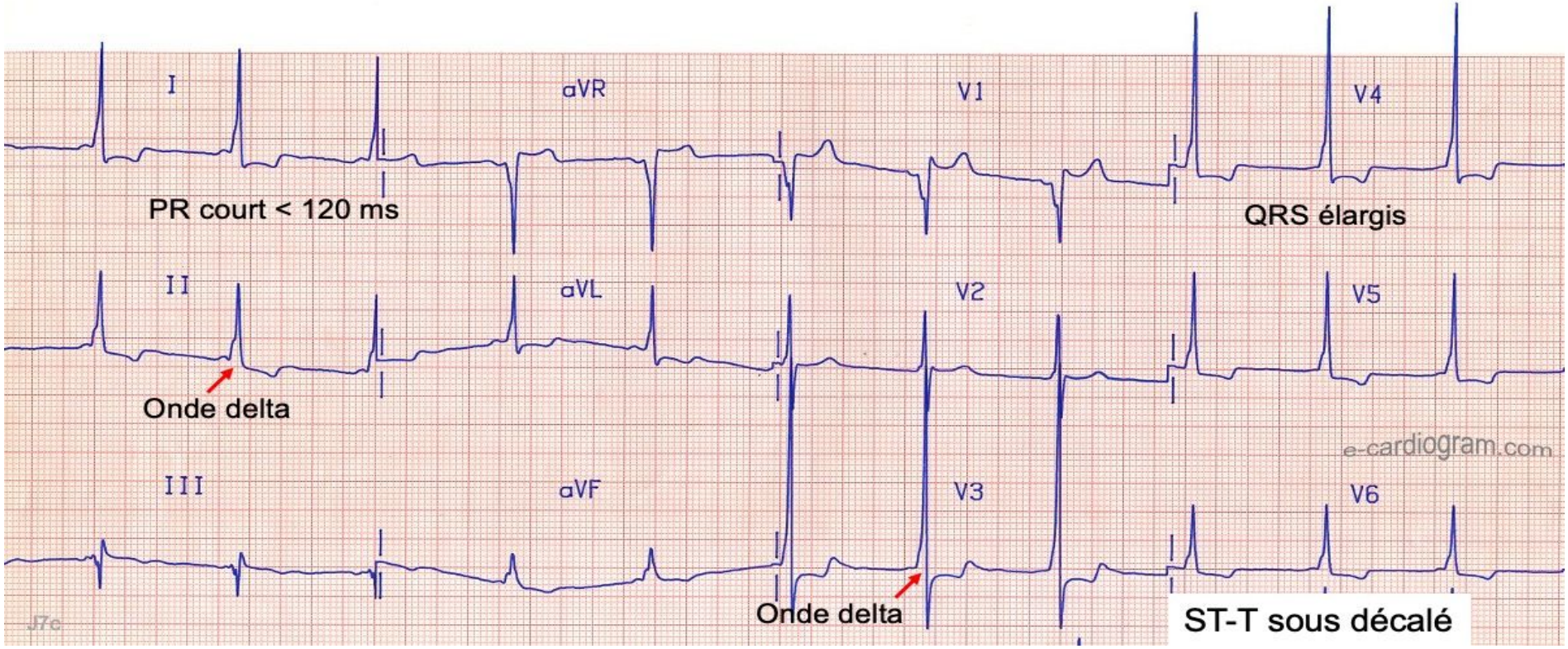
- **Dysfonction sinusale :**
  - dès que les pauses dépassent 4 à 6 secondes chez les sujets jeunes et 3 secondes chez les sujets âgés ;
  - parfois dans le cadre de la maladie de l'oreillette (associée à de la fibrillation atriale).

- **Défaillance d'un stimulateur cardiaque,** par déplacement ou rupture de sonde ou usure de la batterie.

Préexcitation ventriculaire

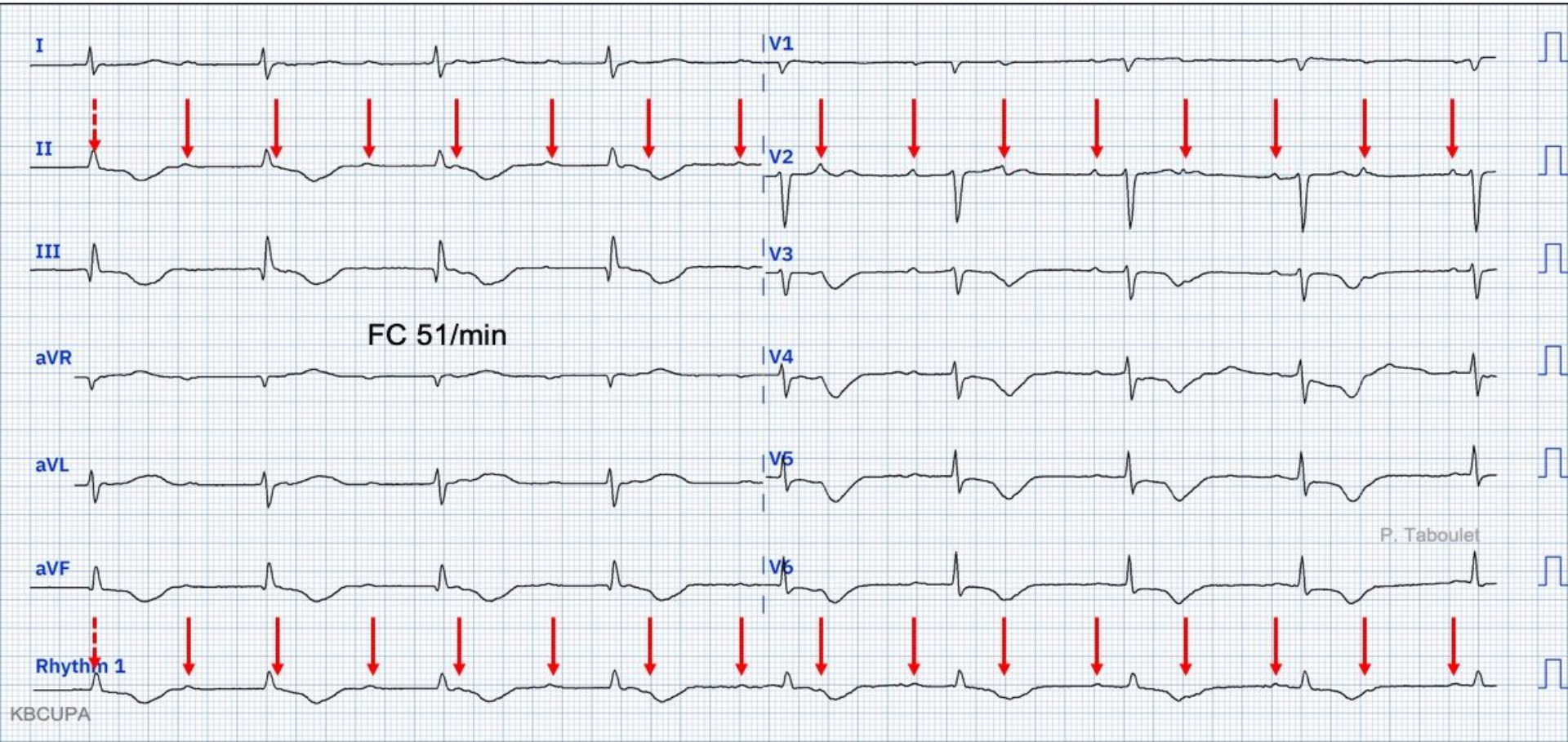
Primo-dépolarisation d'une partie du myocarde ventriculaire par une voie de conduction anormale en compétition avec les voies normales de conduction AV.

La forme typique associe un raccourcissement de l'**intervalle P-R**, une **onde delta**, un **élargissement des complexe QRS** et des troubles secondaires de repolarisation.



BAV du 3ème degré

BAV complet (DAV) avec rythme échappement 51/min à QRS fins
(en faveur d'un bloc intranodal)



3 .HYPOTENSIONS ARTÉRIELLES

- Opposer les hypotensions avec tachycardie sinusale (adaptation normale du barro-réflexe) aux hypotensions avec bradycardie sinusale paradoxale (**réaction vas-ovagale**).

3.1.Hypotensions avec tachycardie sinusale réflexe en général

- **Hypotensions artérielles iatrogènes** : ce sont parmi les causes principales chez le sujet âgé par surdosage en médicaments anti-hypertenseurs, psychotropes ou déshydratation.

- **Hypotension artérielle orthostatique,** définie par une baisse de **20 mmHg de la pression artérielle systolique ou > 10 mmHg de la pression diastolique en 1 à 3 minutes après le passage à la position verticale (suite à 5–10 minutes de décubitus)**

  - iatrogène (vasodilatateurs …)
  - par dysautonomie surtout chez le diabétique, dans l'amylose ;
  - dans la maladie de Parkinson et autres syndromes extrapyramidaux
  - par hypovolémie, diarrhée… ;
  - fièvre ;
  - idiopathique ;
  - maladies endocriniennes rares (maladie d'Addison, phéochromocytome…).

3.2.Hypotensions avec bradycardie sinusale (paradoxale)

⇒ **Hypotension réflexe ou « situationnelle »**
qui peut s'accompagner d'un certain degré de dysfonction sinusale ou de bradycardie sinusale participant d'un même réflexe à la fois vasodilatateur et cardio-inhibiteur :

- **Par compression du glomus carotidien** et mise en jeu du baro-réflexe (striction cervicale, rasage) : on parle d'hyperréflectivité sinocarotidiennne ;

Attention : *Il s'agit ici du sinus de la carotide pas du noeud sinusal même si ce dernier peut se ralentir lors de la syncope réflexe.*

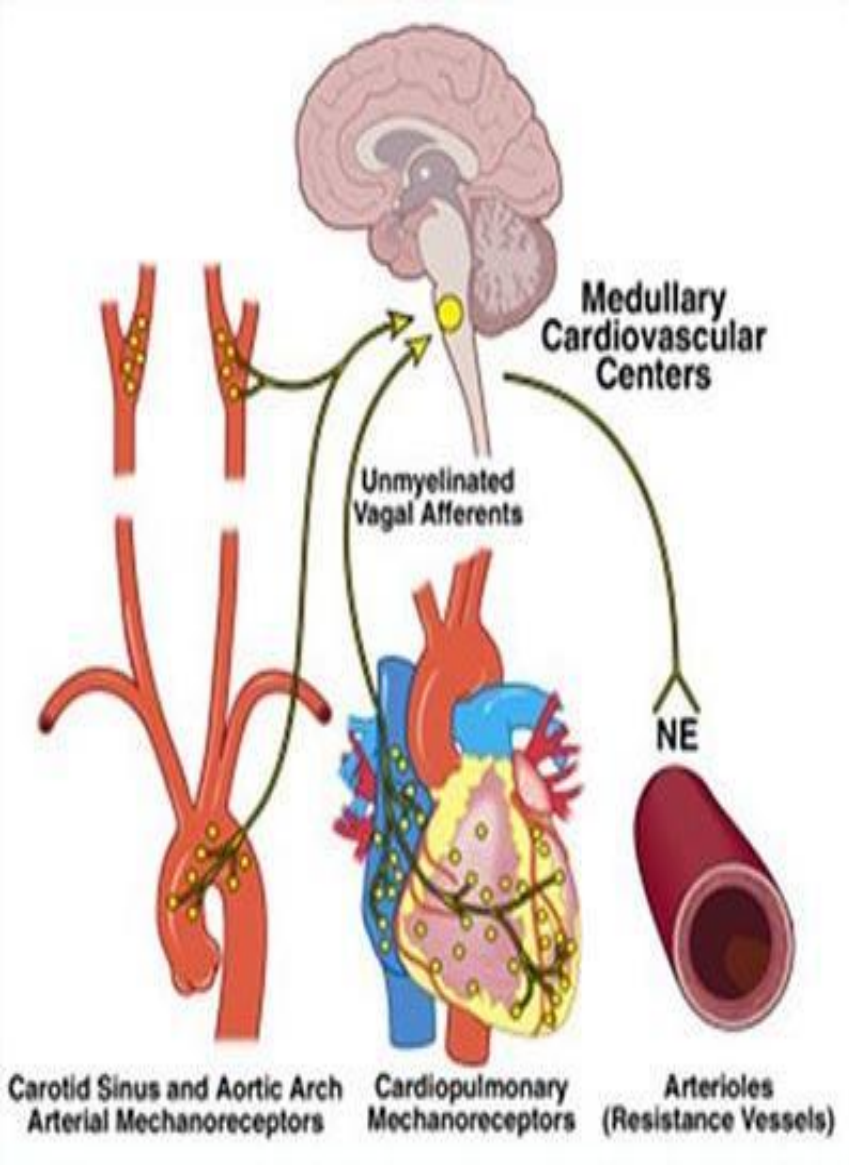
- hypotensions instrumentales (ponctions diverses) ;
- éternuements, quintes de toux (ou ictus laryngé), manoeuvre de Valsalva, trompettistes… ;
- miction, défécation, rarement déglutition ;
- névralgies faciales, etc.

= Hypotension lors de la réaction vaso-vagale :

- elle peut s'accompagner de dysfonction sinusale ou de bradycardie sinusale (jusqu'à 30 secondes d'asystolie dans les formes sévères) ;

- Situationnelle, à la vue du sang, à la station debout prolongée, dans les grandes surfaces, les hôpitaux, les cérémonies religieuses, les transports en commun, à l' émotion, à la douleur ;

- H**ypotension ± bradycardie** parfois prédominante à des signes d'accompagnement évocateurs



Syncope du plongeur



MÉCANISME DE LA SYNCOPE

1 a 2 min O2 normal

O2↓↓ → Syncope

Sensations désagréables

« contraction Diaphragme »

Envie de respirer → Fin de l'Apnée

« O2 continue a baisser qq secondes »

CO 2 ↑

Début d'apnée

Phase de lutte

Mk copy right

Forme clinique : SYNCOPE NEUROCARDIOGÉNIQUE

- les syncopes vaso-vagales, les syncopes réflexes ou «situationnelles » et l'hyperréflexie sinocarotidienne.

- Ce sont les syncopes les plus fréquentes sur **coeur sain et ECG normal.**

● Contexte :

- station debout prolongée, confinement, lieux publics ou transports en commun, chaleur, douleur, émotion, vue du sang, stimulus olfactif désagréable pour les syncopes vasovagales ;

- rasage, mouvements du cou, col trop serré pour l'hyperréflexie sinocarotidienne ;

- miction, défécation, douleurs abdominale, toux ou stimulation douloureuse pharyngée pour les syncopes réflexes ;

- attention pour tous les types, la nuit et la période postprandiale sont favorisantes.

● Terrain :

○ sujets jeunes : souvent contexte anxieux et émotif ou dépressif (syncopes vaso-vagales)

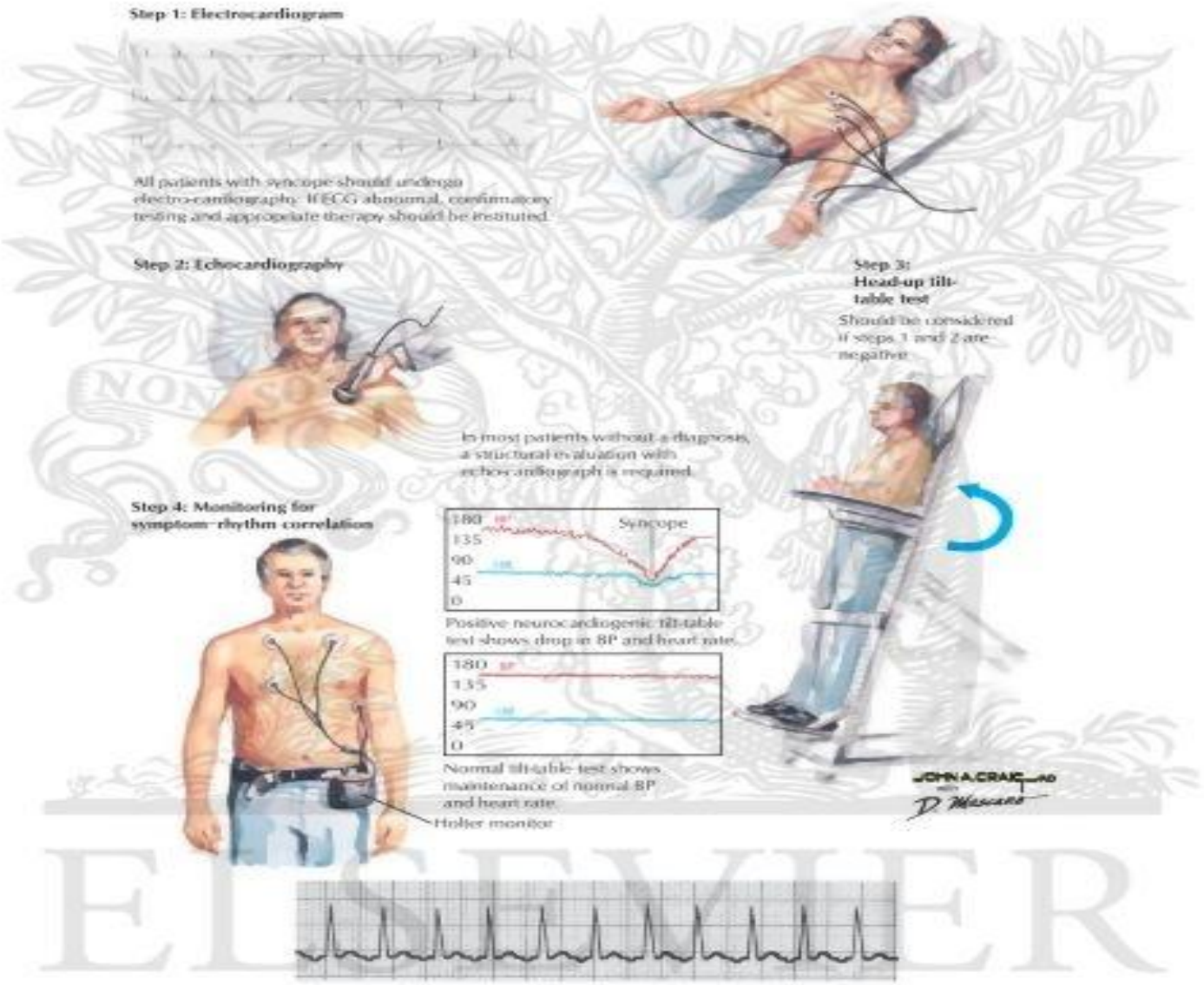
○ hommes âgés (hyperréflexie sinocarotidienne).

- Cest une syncope progressive ou brutale (traumatisante) après des prodromes à type de nausées, vue trouble, faiblesse des jambes qui s'accompagnent de sueurs de nausées parfois de diarrhée ou de douleur abdominale.
- Le tégument est souvent pâle ,Il peut y avoir des myoclonies, la bradycardie peut être parfois sévère avec asystolie.
- Il faut allonger le patient et surélever ses jambes. On note une asthénie profonde et une intolérance à la station debout lors de la phase de récupération.
- Si la syncope est typique, unique, sans facteur de risque (métier, loisir), les investigations doivent être stoppées, dans les autres cas on discute du test d'inclinaison +++

❖Test d'inclinaison

- Examen réalisé dans un environnement calme, patient à jeun.
- Surveillance continue de la pression artérielle et de l'ECG.
- Période de décubitus initial d'au moins 5 minutes.
- Patient incliné sur table basculante, angle de 60 à 70° tête en haut.
- Période d'inclinaison d'au moins 20 minutes et de 45 minutes au plus.
- Sensibilisation par l'isoprénaline ou trinitrine sublinguale.
- Le test est défini comme positif en cas de survenue d'une syncope vaso-vagale associant hypotension et/ou bradycardie parfois sévère.

Syncope: Four-Step Management Approach

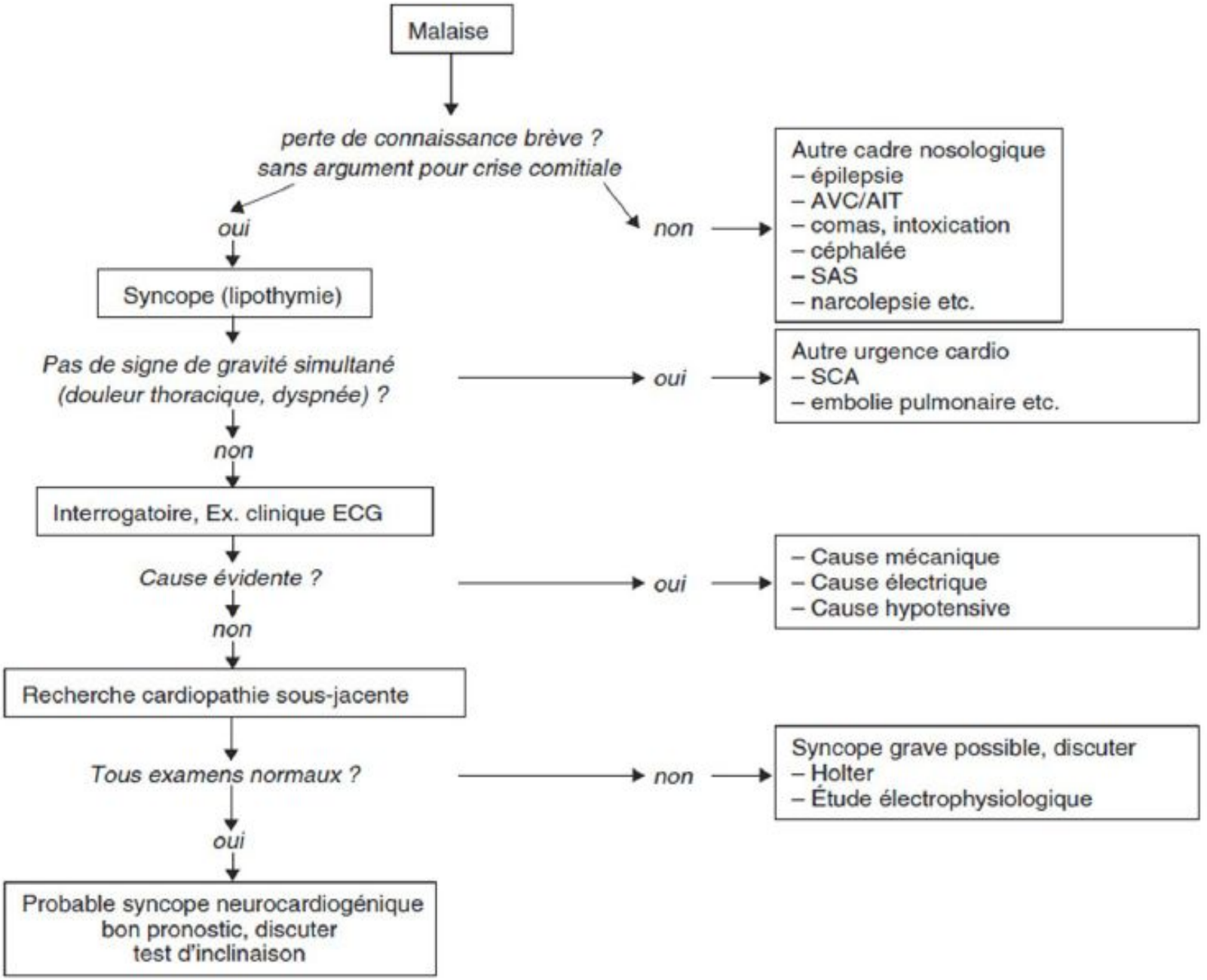


Ambulatory monitoring recommended for patients with negative evaluation; Duration of monitoring dependent on frequency of episodes; For daily symptoms, 48-hour monitor adequate

© ELSEVIER, INC. – NETTERIMAGES.COM

❖Une hyperréflexie sinocarotidienne est recherchée :

- > 40 ans ;
- après auscultation minutieuse des carotides en raison du risque d'accident vasculaire cérébral.
- Elle est réalisée en position couchée puis debout, par massage ferme et unilatéral d'une carotide puis l'autre, au bord antérieur du muscle sterno-cléido-mastoïdien, au niveau du cartilage cricoïde, pendant au moins 5 secondes et au plus 10 secondes.
- La réponse est considérée comme positive en cas de reproduction d'une syncope ou lipothymie en rapport avec une bradycardie et/ou une baisse de la pression artérielle, en l'absence de tout autre diagnostic (diagnostic d'élimination).


Malaise
perte de connaissance brève ?
sans argument pour crise comitiale
non
Autre cadre nosologique
– épilepsie
– AVC/AIT
– comas, intoxication
– céphalée
– SAS
– narcolepsie etc.
oui
Syncope (lipothymie)
Pas de signe de gravité simultané
(douleur thoracique, dyspnée) ?
oui
Autre urgence cardio
– SCA
– embolie pulmonaire etc.
non
Interrogatoire, Ex. clinique ECG
Cause évidente ?
oui
– Cause mécanique
– Cause électrique
– Cause hypotensive
non
Recherche cardiopathie sous-jacente
Tous examens normaux ?
non
Syncope grave possible, discuter
– Holter
– Étude électrophysiologique
oui
Probable syncope neurocardiogénique
bon pronostic, discuter
test d'inclinaison

6.CONCLUSION

- Pour prévenir une syncope, il est conseillé d'éviter le changement brutal de la position couchée à la position debout et d'éviter les émotions fortes.

- Lorsque la syncope survient, il est recommandé de s'allonger immédiatement quelque soit l'endroit, de surélever les jambes pour permettre une meilleure circulation du sang jusqu'au cœur et de contrôler sa respiration pour éviter l'hyperventilation.

- Les médicaments pouvant avoir des effets sur la pression artérielle sont à éviter.